

# Здоровый новорождённый

Первый час · скрининги · профилактика · критерии выписки

## 1. КТО СЧИТАЕТСЯ ЗДОРОВЫМ

Здоровый новорождённый — доношенный ребёнок, родившийся в удовлетворительном состоянии, у которого нет заболеваний и патологических состояний. Диагноз ставится, если выполнено **всё**:

- Спонтанное дыхание в течение **30 секунд** после рождения и ЧСС **более 100 в минуту**.
- По физикальным данным — без видимых пороков развития.
- Нет нарушений по данным клинического, лабораторного и инструментального обследования.
- Не потребовалась дополнительная медицинская помощь, связанная с изменением состояния в родильном доме.
- За время наблюдения в роддоме не выставлен другой диагноз.

|                   |                         |                 |                                                              |
|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Масса тела        | <b>2300-4100 г</b>      | Длина тела      | <b>45-53 см</b>                                              |
| Окружность головы | <b>31-36 см</b>         | Частота дыхания | <b>30-60 в минуту</b>                                        |
| ЧСС в покое       | <b>110-160 в минуту</b> | Оценка          | <b>По центильным таблицам международных стандартов роста</b> |

## 2. ТАЙМЛАЙН

| Когда                | Что делаем                                                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Первые секунды       | Оценить состояние и потребность в реанимации. Если реанимация не нужна — выложить на живот или грудь матери, контакт «кожа к коже» <b>при неотсечённой пуповине</b> |
| <b>60-120 секунд</b> | <b>Отсроченное пережатие и пересечение пуповины</b> , если нет необходимости в немедленной помощи матери или ребёнку                                                |
| 1-я и 5-я минуты     | Оценка по шкале Апгар: дыхание, сердцебиение, цвет кожи, рефлексы, мышечный тонус                                                                                   |
| <b>Первый час</b>    | <b>Первое прикладывание к груди</b> — независимо от способа родоразрешения. Большинство детей готовы к кормлению уже через 15 минут                                 |
| После прикладывания  | И только после него: взвешивание, измерение окружностей и длины тела, обработка культи пуповины. Профилактика инфекции глаз, витамин К                              |
| Первые 24 часа       | Вакцинация против гепатита В                                                                                                                                        |
| Не позже 2 часов     | Повторный осмотр дежурным врачом-неонатологом — в родзале перед переводом или уже в отделении                                                                       |
| Первые сутки         | Осмотр медсестрой <b>каждые 3-3,5 часа</b>                                                                                                                          |
| 24-48 часов          | Забор крови на неонатальный скрининг (у доношенного)                                                                                                                |
| <b>36-48 часов</b>   | <b>Скрининг на критические ВПС</b>                                                                                                                                  |
| 3-и сутки            | Вакцинация БЦЖ (при ранней выписке — с третьих суток)                                                                                                               |
| 3-4-е сутки          | Аудиологический скрининг — вызванная отоакустическая эмиссия                                                                                                        |
| Ежедневно            | Осмотр не реже 1 раза в день; при ухудшении — не реже 1 раза в 6 часов                                                                                              |

Санация верхних дыхательных путей, зондирование желудка и оценка проходимости прямой кишки зондом проводятся **только по показаниям**. Глубокая и агрессивная фарингеальная стимуляция может вызвать аритмию, ларингоспазм, бронхоспазм и апноэ.

3. СКРИНИНГ НА КРИТИЧЕСКИЕ ВПС — 36-48 ЧАСОВ

**Условия проведения**  
Ребёнок должен быть **сыт и согрет**, в состоянии спокойного бодрствования или сна. Измерения пре- и постдуктально (правая рука и любая нога) при одном мониторе — с промежутком **не более 1-2 минут**. Если во время измерения состояние сменилось (сон ↔ бодрствование ↔ плач) — повторить через 5 минут после достижения покоя.

| Что оцениваем            | Первичный скрининг пройден, если                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Цвет кожи и слизистых    | Розовые                                                                  |
| Периферическая пульсация | Удовлетворительная, симметричная на правой плечевой и бедренных артериях |
| Пульсоксиметрия          | Пре- и постдуктально <b>95% и более</b>                                  |
| Разница SpO <sub>2</sub> | <b>Менее 3%</b> между пре- и постдуктальным значением                    |

| Расширенный скрининг | Как                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Когда                | Если первичный скрининг <b>не пройден</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Что делать           | <b>Трёхкратное ежечасное</b> пре- и постдуктальное измерение пульсоксиметрии и систолического АД, оценка периферической пульсации, цвета кожи и слизистых, темпов диуреза                                                                         |
| Пройден, если        | Пульсация удовлетворительная и симметричная; кожа и слизистые розовые; диурез адекватный; SpO <sub>2</sub> пре- и постдуктально <b>≥ 95%</b> с разницей <b>менее 3%</b> в динамике; разница САД пре- и постдуктально <b>10 мм рт. ст. и менее</b> |
| Не пройден           | Назначается <b>эхокардиография</b> для исключения критического ВПС                                                                                                                                                                                |

Манжеты для измерения АД — одноразовые детские (3,3–5,6; 4,2–7,1; 5,4–9,1; 6,9–11,7 см). Манжета должна покрывать не менее двух третей длины плеча или бедра и охватывать всю окружность конечности. При «пройденном» скрининге в истории болезни делается пометка «скрининг на критические ВПС пройден».

4. СКРИНИНГИ: НЕОНАТАЛЬНЫЙ И СЛУХОВОЙ

| Скрининг                                              | Когда и как                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неонатальный и расширенный неонатальный               | Кровь из пятки <b>через 3 часа после кормления</b> : у доношенного в <b>24-48 часов</b> , у недоношенного на <b>7-е сутки (144-168 часов)</b> . Два фильтровальных тест-бланка от медико-генетической консультации; результат — в срок до 10 дней. Фиксируется в истории развития и в выписном эпикризе |
| Аудиологический                                       | Всем в роддоме в <b>3-4 дня</b> — вызванная отоакустическая эмиссия. Дети из группы риска по тугоухости и те, кто отнесён к ней по результату, направляются в сурдологический центр <b>до 3 месяцев</b> для ВОАЭ и КСВП                                                                                 |
| Группа крови, Кумбс, билирубин                        | Селективно, по клиническим показаниям. В родблоке при показаниях — экспресс-метод цоликлонами с записью на титульном листе. Полную лабораторную панель проводят <b>только детям с риском ГБН</b>                                                                                                        |
| Общий анализ крови                                    | Селективно, по показаниям                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| НСГ, ЭхоКГ, УЗИ живота, почек, тазобедренных суставов | Селективно, по показаниям и с учётом возможностей учреждения                                                                                                                                                                                                                                            |

**В день БЦЖ — никаких других парентеральных манипуляций**  
В день вакцинации против туберкулёза ребёнку **не проводят никаких других парентеральных вмешательств, включая неонатальный скрининг**. Планируйте забор крови и вакцинацию на разные дни.

## 5. ПРОФИЛАКТИКА В РОДДОМЕ

| Что           | Как                                                                                                | Детали                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инфекции глаз | Эритромициновая глазная мазь                                                                       | После протирания каждого века — полоса <b>0,5-1 см</b> в каждый нижний конъюнктивальный мешок, лёгкий массаж век; избыток стереть через минуту                                                                    |
| Витамин К     | Фитоменадион <b>1 мг внутримышечно</b> в первые часы                                               | Недоношенным менее 36 недель с массой $\geq 2500$ г — 1 мг в/м или в/в; при массе $< 2500$ г — <b>0,4 мг/кг</b> . Действует через 30 минут. Нужно письменное согласие матери                                      |
|               | Если фитоменадиона нет — менадиона натрия бисульфит 1%                                             | <b>1-1,5 мг/кг/сут</b> (0,1-0,15 мл/кг/сут) в/м, но не более 4 мг/сут, 1-3 раза в сутки.<br><b>Действие начнётся только через 8-24 часа</b>                                                                       |
| Гепатит В     | Первая доза <b>всем в первые 24 часа</b>                                                           | Схема 0-1-6 месяцев. У детей от матерей-носителей и больных — <b>0-1-2-12 месяцев</b>                                                                                                                             |
| Туберкулёз    | БЦЖ строго <b>внутрикожно</b> на границе верхней и средней трети наружной поверхности левого плеча | Должна образоваться беловатая папула <b>7-9 мм</b> , исчезающая через 15-20 минут.<br><b>Введение под кожу недопустимо</b> — холодный абсцесс. Реакция развивается через 4-6 недель, обрабатывать её ничем нельзя |

Активно-пассивная иммунизация (вакцина + иммуноглобулин человека против гепатита В) показана детям от матерей с острым вирусным гепатитом В, ранних реконвалесцентов и носительниц HBsAg. Вакцина вводится **через 2 часа после иммуноглобулина**.

## 6. ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

| Противопоказания со стороны матери                               | Со стороны ребёнка                                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Онкологические заболевания, требующие химиотерапии</b>        | <b>Галактоземия</b>                                |
| <b>Открытая форма туберкулёза с бацилловыделением</b>            | <b>Фенилкетонурия</b>                              |
| <b>Особо опасные инфекции — натуральная оспа, сибирская язва</b> | <b>Болезнь кленового сиропа (валинолейцинурия)</b> |
| <b>ВИЧ-инфекция матери</b>                                       |                                                    |
| <b>Психические заболевания в стадии обострения</b>               |                                                    |
| <b>Острый гепатит В и С в активной фазе</b>                      |                                                    |
| <b>Препараты, несовместимые с грудным вскармливанием</b>         |                                                    |

- Грудной имплантат **не** противопоказание. Размер и форма груди и соска на функцию молочной железы не влияют.
- При HBsAg у матери грудное вскармливание возможно **после** активно-пассивной иммунизации ребёнка.
- При гриппе, ветряной оспе, COVID-19 вскармливание можно продолжить при дистанцировании и соблюдении гигиены, либо кормить сцеженным молоком.
- Если мать получает противопоказанный препарат — искать аналог, совместимый с грудным вскармливанием.
- Длительность сосания у здоровых доношенных **не ограничивают**. Для полноценной лактации нужно совместное пребывание матери и ребёнка.

7. УХОД И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

| Что                   | Как                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура в родзале | Не менее 25 °С, без сквозняков; включить источник лучистого тепла, согреть лоток и пелёнки. Гипотермия начинается при температуре тела 36 °С и ниже                                                             |
| Пуповинный остаток    | Сухое ведение. Стерильные условия не нужны. Не обрабатывать антисептиками — ни этанолом, ни перманганатом калия, ни метилтиониния хлоридом. При загрязнении — промыть водой и осушить. Отпадает на 1-2-й неделе |
| Кожа                  | Купать в тёплой водопроводной воде без антисептиков и настоев трав. Шампуни и пены — не чаще 1-2 раз в неделю. Средства для ухода — на водной основе                                                            |
| Подгузники            | Менять при наполнении и сразу после дефекации, в течение дня устраивать воздушные ванны                                                                                                                         |

8. КРИТЕРИИ ВЫПИСКИ

| Критерий         | Норма                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кормление        | Активно сосёт из груди и/или из бутылочки через соску                                                                                                                                    |
| Усвоение питания | Питание усваивается                                                                                                                                                                      |
| Температура тела | Нормальная                                                                                                                                                                               |
| Убыль массы тела | Менее 10% от массы при рождении                                                                                                                                                          |
| Обследования     | По выполненным по показаниям исследованиям нет патологических изменений либо отклонения незначительные, не угрожающие жизни и здоровью и не требующие стационарного наблюдения и лечения |

При выписке медицинская организация оформляет документацию и передаёт информацию о выписке в поликлинику по месту фактического проживания для организации патронажа на дому. Результаты аудиологического скрининга и забора крови на неонатальный скрининг вносятся в выписную справку; если отметки нет — исследование проводится в детской поликлинике.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Здоровый новорожденный, рожденный в условиях стационара» — ID 924\_1, размещены 08.07.2025. [https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/924\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/924_1)
- Критерии диагноза, нормативы осмотра, сроки и порядок скринингов, дозы профилактических препаратов, правила ухода и критерии выписки приведены по разделам 2, 3, 5 и 6 КР «Здоровый новорожденный, рожденный в условиях стационара» и приложению Б тех же КР.